Hadi Health

un’iniziativa della Fondazione bioERGOtech



PIANO INDUSTRIALE · OTTOBRE 2026

Meno tempo tra il dato e la decisione.

Software per le aziende sanitarie e le regioni italiane: Frankura per il percorso oncologico, VIS Pharma Compass per la spesa farmaceutica.

Documento riservato a investitori e partner.

Fondazione bioERGOtech ETS · Taranto e Zurigo · info@bioergotech.org

SINTESI

Hadi Health in una pagina

Hadi Health è l'iniziativa con cui la Fondazione bioERGOtech porta il proprio software nelle aziende sanitarie e nelle regioni. Vende e gestisce due prodotti che hanno lo stesso acquirente: **Frankura**, che prepara i casi oncologici per i gruppi multidisciplinari, e **VIS Pharma Compass**, che mostra dove si può intervenire prima sulla spesa farmaceutica.

> **Lavoriamo sul tempo che passa tra i dati che un ospedale o una regione hanno già e la decisione che ne segue.**

1.392 ore

di lavoro medico che i moduli A, B e C di Frankura possono liberare ogni anno all'ASL VCO, pari a 66.816 €. Stima della proposta di progetto, da misurare nel progetto pilota.

808.000 €

di valore annuo, scenario prudenziale (404.000 € nel minimo), stimato da VIS sui dati reali delle quattro ASL abruzzesi.

15 enti

nella nostra rete, in 9 regioni: 3 lavorano con noi sui prototipi, 12 sono contatti diretti. I loro territori contano 18,3 milioni di residenti.

17,8 mln €

valore annuo potenziale per gli enti di quei territori, in tempo medico e in spesa farmaceutica, scenario prudenziale (12,4 mln € nel minimo). Non è un ricavo di Hadi Health.

DOVE SIAMO

- **Frankura:** prototipo sviluppato con la SOC Oncologia dell'ASL VCO, sul percorso dalla visita al gruppo multidisciplinare. Il progetto pilota è in attesa dell'approvazione regionale e non c'è ancora un accordo scritto.
- **VIS Pharma Compass:** prototipo funzionante su 261.153 record di erogazione delle quattro ASL abruzzesi; prova in corso con l'ASL Caserta e l'ASL Salerno.
- Hadi Health è oggi un progetto della Fondazione, non ancora una società.

COSA CERCHIAMO

Enti che adottino i prodotti partendo da un'analisi diagnostica o da un progetto pilota con misure prima e dopo.

Partner industriali e tecnologici per l'integrazione con i sistemi ospedalieri e la distribuzione.

Partner clinici e scientifici per la validazione e il percorso di marcatura CE di Frankura.

Partner finanziari con cui costituire la società e sostenerne i primi tre anni.

I valori economici sono stime costruite su due casi di riferimento (l'analisi di VIS sui dati delle quattro ASL abruzzesi e il progetto di Frankura per l'ASL VCO) e su dati pubblici; non sono ancora misure prima e dopo. Metodo e ipotesi sono nel capitolo 7 e in appendice.

01 · LA STORIA

Dal team ai progetti che accettiamo

La Fondazione bioERGOtech è nata a Taranto nell'aprile 2025 e lavora tra Taranto e Zurigo. Il team riunisce competenze di ingegneria biomedica, biostatistica, sviluppo software, diritto e design, con consulenti in reumatologia, market access e investimenti in sanità; le competenze cliniche di ogni progetto vengono dai medici e dai farmacisti degli enti con cui lavoriamo. Non partiamo da una tecnologia: partiamo da una persona che ha un problema, ne risponde e non riesce a risolverlo con il tempo e i dati che ha davanti.

Il filo comune dei progetti che abbiamo accettato non è la pianificazione delle terapie, di cui si occupano già in molti. È il tempo. Ospedali e regioni possiedono già gran parte dei dati che servono per decidere, ma li leggono tardi. Un oncologo ricopia la storia clinica dalla scheda di accoglienza a quella del gruppo multidisciplinare. Una nota di credito dei registri AIFA scade prima di essere richiesta. Un biosimilare è disponibile da mesi, ma la spesa resta sul farmaco originatore. In ciascun caso il dato esiste; manca il tempo per trasformarlo in una decisione.

La frase che unisce Fondazione e Hadi Health

> **Lavoriamo sul tempo che passa tra i dati che un ospedale o una regione hanno già e la decisione che ne segue. La Fondazione bioERGOtech individua dove quel tempo si perde; Hadi Health porta il software che lo accorcia, con Frankura nei gruppi oncologici multidisciplinari e con VIS Pharma Compass nella spesa farmaceutica. La decisione resta a chi ne risponde, e l'effetto si misura prima e dopo, in ore e in euro.**
>
> In breve: **Meno tempo tra il dato e la decisione.** In inglese: **Less time between data and decision.**

Tre criteri per accettare un progetto

01

Il problema ha un responsabile

Un clinico, un farmacista o un dirigente lo vive ogni giorno, ce lo porta e resta titolare della decisione. Il software la prepara, non la sostituisce.

02

I dati esistono già

Lavoriamo sui flussi e sui sistemi che l'ente usa oggi. Non chiediamo di produrre dati nuovi: rendiamo leggibili in tempo quelli che oggi arrivano tardi.

03

Il ritardo si misura

Prima e dopo l'intervento, in ore di lavoro e in euro, con numeri che il committente può verificare. Se l'effetto non si può misurare, non proponiamo l'intervento.

Due ruoli distinti

FONDAZIONE BIOERGOTECH ETS

- Individua i bisogni con chi li vive: medici, farmacisti, direzioni.
- Fa ricerca e validazione scientifica, pubblica i risultati.
- Cura la rete clinica, la formazione e i progetti finanziati.

HADI HEALTH

- Porta i prodotti fino all'uso quotidiano negli enti.
- Una volta costituita la società, firmerà i contratti con aziende sanitarie e regioni e ne risponderà.
- Gestisce conformità (GDPR, MDR, AI Act), assistenza e misura dell'effetto.

Un ente del Terzo settore può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale solo se lo statuto lo consente e se restano secondarie e strumentali (D.Lgs. 117/2017, art. 6). Vendere e gestire software clinico per enti pubblici richiede una struttura d'impresa, con responsabilità contrattuali, assicurative e di certificazione proprie. Hadi Health è quella struttura: oggi un progetto della Fondazione, domani una società. Fino ad allora la controparte di contratti, analisi diagnostiche e progetti pilota è la Fondazione bioERGOtech ETS. **Hadi**, in arabo, significa guida. Una guida conosce la strada e accorcia il cammino; la meta la sceglie chi viaggia.

Lo stesso acquirente, due ritardi

Le aziende sanitarie e le regioni pagano sia il tempo dei clinici sia i farmaci. In entrambi i casi hanno già i dati, ma li usano in ritardo.

La spesa per acquisti diretti supera il tetto in ogni regione

Nel 2025 la spesa per acquisti diretti delle strutture pubbliche (farmaci di classe A e H, al netto dei payback) è stata di **16,0 mld €**, pari all'11,82% del fabbisogno sanitario nazionale contro un tetto dell'8,30%. Lo sforamento è di **4,77 mld €** e nessuna regione rientra nel tetto. La Campania ha lo sforamento maggiore in euro, 678 mln €.

Molte opportunità di risparmio si leggono già nei dati dell'azienda sanitaria e nelle fonti pubbliche: le scadenze brevettuali, i biosimilari disponibili, le note di credito dei registri AIFA. Il problema è il ritardo con cui l'organizzazione le individua e interviene.

Il tempo dei medici finisce nella documentazione

In Italia si stimano circa **390.000** nuove diagnosi di tumore all'anno; nel 2022 le unità di oncologia medica attive erano 323. Tra il 2012 e il 2022 i posti letto pubblici di oncologia medica sono scesi da 5.262 a 4.159.

Nella Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta ogni nuovo paziente passa dal Centro Accoglienza e Servizi (CAS) al Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC); le altre reti regionali hanno percorsi analoghi, spesso con nomi diversi. Ogni passaggio richiede di ricopiare e riassumere dati che esistono già. All'ASL VCO la proposta di progetto stima in **1.392 ore** l'anno il lavoro medico che si può liberare.

Le regioni della rete: spesa per acquisti diretti in percentuale del fabbisogno sanitario, 2025



Acquisti diretti di farmaci di classe A e H al netto dei payback, sul fabbisogno sanitario di ciascuna regione (AIFA, consuntivo 2025). Accanto a ogni barra lo sforamento in euro. Le 9 regioni in cui abbiamo un interlocutore superano tutte il tetto, dalla Lombardia alla Sardegna.

Perché adesso

Le regole sono chiare

La legge 132/2025 sull'intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025, stabilisce all'art. 7 che in sanità l'IA è di supporto e la decisione resta al medico. È il principio su cui sono costruiti entrambi i prodotti.

I medici usano già l'IA

Secondo l'Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, il 61% degli specialisti usa l'IA generativa, quasi sempre su piattaforme generaliste. Gli enti hanno bisogno di strumenti conformi, dentro i loro sistemi.

Dopo il PNRR

Un terzo delle strutture pubbliche teme di ridimensionare i progetti digitali dopo il PNRR, e la metà indica le risorse limitate come primo ostacolo. Servono strumenti che si possano finanziare con le risorse ordinarie di parte corrente e che si ripaghino.

Frankura: il percorso oncologico, dalla visita al referto

Frankura si integra con il software che l'ospedale usa già e segue il paziente dalla prima visita al referto del gruppo multidisciplinare. Non sostituisce il giudizio clinico: lo prepara e lo struttura.

MODULO A

La visita

Registra la visita CAS e ambulatoriale e compila la scheda nella cartella oncologica.

MODULO B

Dal CAS al GIC

Trasferisce la storia clinica nella scheda GIC, senza ricopiature e senza dati mancanti.

MODULO C

La sintesi del caso

Una pagina con le opzioni indicate dalle linee guida AIOM ed ESMO. Il gruppo la conferma, la modifica o la respinge.

MODULO D

Il referto

Referti standardizzati e interoperabili (FSE 2.0, HL7 FHIR, PDF/A), leggibili dal medico di medicina generale.

Il caso dell'ASL VCO

L'ASL VCO gestisce ogni anno 1.100 schede CAS, 525 visite oncologiche e 1.547 casi discussi nei GIC. Secondo la stima della proposta di progetto (per esempio 15 minuti risparmiati per visita), i moduli A, B e C possono liberare le ore indicate nella tabella, valutate al costo orario del personale medico di 48 €. Ogni modulo si può attivare indipendentemente dagli altri. Il modulo D porta benefici di qualità che non abbiamo quantificato.

Frankura è stato sviluppato con la SOC Oncologia dell'ASL VCO, diretta dal dott. Mario Franchini. Il progetto pilota è in attesa dell'approvazione regionale e non c'è ancora un accordo scritto: oggi Frankura non è in uso nella cura. Nel progetto pilota misureremo queste grandezze prima e dopo l'installazione.

MODULO	ORE/ANNO	VALORE/ANNO
A. Acquisizione dei dati della visita	406 h	19.488 €
B. Trasferimento dalla scheda CAS alla scheda GIC	600 h	28.800 €
C. Sintesi del caso per la riunione GIC	386 h	18.528 €
Totale	**1.392 h**	**66.816 €**

PER CHI

Direzione sanitaria, oncologia e rete oncologica regionale. La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta conta 36 CAS e 283 GIC: una sola rete offre decine di punti di installazione con lo stesso percorso.

PREZZO

Licenza per ospedale da 50.000 € a 150.000 €, in base ai moduli attivati, alla dimensione della struttura e alle risorse necessarie, più un canone annuo di gestione.

DOVE SI DISTINGUE

Le soluzioni più diffuse trascrivono la visita. Frankura prepara il lavoro del gruppo multidisciplinare, che è la parte più lunga del percorso e quella che queste soluzioni non coprono.

VIS Pharma Compass: dove intervenire prima sulla spesa

VIS Pharma Compass è uno strumento di analisi in sola lettura per i servizi farmaceutici aziendali, la direzione sanitaria e il servizio farmaceutico regionale. Riconcilia acquisti ed erogazioni con il bilancio, segnala scadenze brevettuali e biosimilari non usati, confronta le aziende della stessa regione e individua le note di credito dei registri AIFA ancora da richiedere, prima che scada il termine.

> **Il valore non sta nel produrre un'informazione che non esiste, ma nel ridurre il ritardo con cui l'organizzazione reagisce a un'opportunità che esiste già.**
>
> VIS Pharma Compass, Descrizione del prodotto

Il caso dell'Abruzzo

Il prototipo funziona su dati reali delle quattro aziende sanitarie abruzzesi: 261.153 record di erogazione, 452,7 mln € di spesa annua. Non c'è ancora un contratto commerciale: è una verifica del metodo sui loro dati. Il modello lavora su dati aggregati per struttura, molecola e periodo e non produce informazioni sul singolo paziente.

La tabella riporta il valore annuo per fase, nello scenario prudenziale. Lo scenario minimo è la metà, 404.000 €. In più, si stima che VIS restituisca all'attività di governo della spesa 71 giornate di lavoro dei farmacisti all'anno (497 ore), poco più di tre mesi di un dirigente farmacista a tempo pieno: un'ipotesi costruita su una struttura di dimensione media, da verificare sui volumi dell'ente.

VIS non è un dispositivo medico: non interviene su decisioni relative al singolo paziente.

FASE	VALORE/ANNO
Programmazione governo del prontuario e della crescita della spesa	205.000 €
Acquisto scadenze brevettuali (240.000 €) e biosimilari disponibili (144.000 €)	384.000 €
Rendicontazione note di credito dei registri AIFA richieste in tempo	60.000 €
Benchmark fra aziende confronto per attività fra le ASL della stessa regione	159.000 €
Totale prudenziale	**808.000 €**

Listino

VOCE	AZIENDA SINGOLA	CONFIGURAZIONE REGIONALE
Analisi diagnostica Tre settimane sui dati dell'ente, senza installazione	9.000 €	9.000 €
Cruscotto e radar scadenze (M1+M2) In esercizio sul prototipo	26.000 €/anno	
Con registri, File F e flussi (M1+M2+M3) M3 in fase di completamento	36.000 €/anno	
Configurazione completa Tutti i moduli: M6 (solo in regione) in esercizio, M4, M5 e M8 in completamento, M7 in sviluppo	72.000 €/anno	135.000 €/anno più 6.000 € per azienda
Attivazione, una tantum	6.000 €	15.000 € più 2.000 € per azienda

Prezzo per modulo e per perimetro, non per utente; canone fisso con fatturazione trimestrale posticipata. Al sesto mese, se gli indicatori concordati non sono raggiunti, l'ente può recedere senza oneri: il suo rischio è limitato a un semestre di canone e all'attivazione.

Perché Frankura e VIS stanno nella stessa impresa

I due prodotti risolvono problemi diversi, ma per lo stesso ente, con lo stesso metodo e con le stesse regole sui dati. Ogni contratto apre la porta all'altro prodotto.

	FRANKURA	VIS PHARMA COMPASS
Chi compra	Direzione generale e sanitaria dell'ASL o dell'ospedale; rete oncologica regionale	Direzione generale dell'ASL; servizio farmaceutico regionale
Chi lo usa	Oncologi, componenti dei GIC, personale del CAS	Farmacisti, controllo di gestione, direzione sanitaria
Dati di partenza	Cartella oncologica, schede CAS e GIC, referti	Flussi di acquisto ed erogazione, registri AIFA, bilancio
Effetto da misurare	Ore di lavoro medico liberabili per paziente	Euro di spesa e giorni di reazione, per opportunità
Qualificazione	Modulo C da trattare come dispositivo medico; per i moduli A, B e D la lettura come non dispositivi va confermata con una valutazione regolatoria	Non è un dispositivo medico
Prezzo	Licenza da 50.000 € a 150.000 € per ospedale, più canone	Da 26.000 € a 72.000 € l'anno per azienda; regione da 135.000 €
Stato	Prototipo sviluppato con l'ASL VCO; progetto pilota in attesa dell'approvazione regionale	Prototipo sui dati delle quattro ASL abruzzesi; prova in corso a Caserta e Salerno

Le stesse regole sui dati

L'ente resta titolare del trattamento e il fornitore, oggi la Fondazione e poi la società, agisce come responsabile (GDPR, art. 28). Elaborazione nell'Unione Europea o nel data center dell'ente, registro degli accessi, restituzione dei dati a fine contratto senza costi di uscita.

Un solo percorso d'acquisto

Lo stesso ufficio acquisti e una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in gran parte comune. Se l'ente acquista i due prodotti insieme, la soglia per l'affidamento diretto si calcola sul valore complessivo dell'intera durata.

Un ponte naturale

Il modulo M5 di VIS misura gli sprechi di allestimento dei farmaci oncologici. Oncologia e farmacia guardano gli stessi pazienti da due lati: la farmacia che adotta VIS conosce già l'oncologia che adotterà Frankura, e viceversa.

Un esempio: l'ASL Salerno con entrambi i prodotti

1.055.372

residenti; circa 6.140 nuovi pazienti oncologici e 363 mln € di spesa farmaceutica all'anno, stimati.

650.000 €

valore annuo di VIS nello scenario prudenziale, 320.000 € nel minimo.

370.000 €

valore annuo di Frankura, pari a circa 7.780 ore di lavoro medico.

178.000 €

il costo per l'ASL nel primo anno, 92.000 € dal secondo, a fronte di un valore stimato da 0,7 a 1,0 mln € l'anno per l'intero territorio, comprese le aziende ospedaliere che vi operano.

VIS in configurazione completa per azienda singola (72.000 € l'anno più 6.000 € di attivazione); Frankura con una licenza di 100.000 €, a metà della fascia di prezzo, e un canone ipotizzato pari al 20% della licenza dal secondo anno. Insieme, i due prodotti superano la soglia dell'affidamento diretto (140.000 €) già nel primo anno. Stime con il metodo del capitolo 7.

Chi conosciamo, e dove

In 9 regioni abbiamo 15 interlocutori che possiamo raggiungere senza intermediari: 3 lavorano con noi sui prototipi, 12 sono contatti diretti. Si tratta di 5 amministrazioni regionali, 7 aziende sanitarie e 3 ospedali.



1 Lavora con noi su un prototipo

4 Contatto diretto

Regione con un referente nell'amministrazione regionale

18,3 milioni

residenti nei territori della rete, il 31% della popolazione italiana.

6,0 mld €

di spesa farmaceutica annua nei territori della rete (AIFA 2025, lordo).

3 + 12

tre enti lavorano già con noi sui prototipi; gli altri dodici li conosciamo e li possiamo coinvolgere da subito.

Confini: ISTAT, via openpolis (CC BY 4.0). I punti delle regioni sono posti all'interno del territorio regionale; quelli di ASL e ospedali sulla città.

06 · LA RETE

Gli enti, uno per uno

In prova: ente che lavora con noi sul prototipo di uno dei prodotti, prima di qualunque contratto. **Contatto diretto**: ente che conosciamo e possiamo raggiungere senza intermediari. Riportiamo nomi e ruoli solo se verificati su fonti pubbliche (siti e atti degli enti, stampa) a ottobre 2026; per le cariche politiche indichiamo l'ufficio. Gli altri nomi sono disponibili su richiesta. Dove l'ente non ha ancora indicato un prodotto, proponiamo entrambi.

	ENTE	REFERENTE	PRODOTTO PROPOSTO	STATO
1	**ASL VCO** Verbania, Piemonte	Mario Franchini Direttore SOC Oncologia	Frankura Progetto pilota in attesa dell'approvazione regionale	IN PROVA
2	**ASL Caserta** Caserta, Campania	Claudia Pagliaro Farmacista ospedaliera	VIS Pharma Compass	IN PROVA
3	**ASL Salerno** Salerno, Campania	Gennaro Sosto Direttore Generale	VIS Pharma Compass	IN PROVA
4	**Regione Campania** Amministrazione regionale	Ugo Trama Dirigente, Settore Accreditamento, HTA e Rapporti con il Mercato	VIS Pharma Compass	CONTATTO DIRETTO
5	**Regione Piemonte** Amministrazione regionale	Assessorato alla Sanità	Frankura	CONTATTO DIRETTO
6	**Regione Abruzzo** Amministrazione regionale	Alberto Costantini Dirigente, Servizio Assistenza Farmaceutica	VIS Pharma Compass VIS provato sui dati delle quattro ASL	CONTATTO DIRETTO
7	**Regione Puglia** Amministrazione regionale	su richiesta	Entrambi	CONTATTO DIRETTO
8	**Ospedale Miulli** Acquaviva delle Fonti, Puglia	su richiesta	Entrambi 600 posti letto, oncologia ed ematologia	CONTATTO DIRETTO
9	**ASL Taranto** Taranto, Puglia	su richiesta	Entrambi	CONTATTO DIRETTO
10	**ASL Gallura** Olbia, Sardegna	su richiesta	Entrambi	CONTATTO DIRETTO
11	**Regione Liguria** Amministrazione regionale	Barbara Rebesco Coordinatrice, DIAR Farmaceutico	VIS Pharma Compass	CONTATTO DIRETTO
12	**Humanitas** Rozzano, Lombardia	su richiesta	Entrambi IRCCS, Cancer Center	CONTATTO DIRETTO
13	**AULSS 9 Scaligera** Verona, Veneto	Marina Tommasi Direttrice Farmacia Ospedaliera di Legnago e Dipartimento dei Servizi	VIS Pharma Compass	CONTATTO DIRETTO
14	**Ospedale Pederzoli** Peschiera del Garda, Veneto	Marco Gambera Farmacista ospedaliero	VIS Pharma Compass Presidio ospedaliero dell'AULSS 9, oncologia accreditata ESMO	CONTATTO DIRETTO
15	**AUSL Modena** Modena, Emilia-Romagna	Mattia Altini Direttore Generale	Entrambi	CONTATTO DIRETTO

07 · QUANTO VALE

Quanto valgono i due prodotti per gli enti della rete

Partiamo da due casi di riferimento, uno per prodotto, costruiti sui dati reali di due enti, e li estendiamo agli altri territori in proporzione a un dato pubblico: per VIS la spesa farmaceutica, per Frankura i nuovi casi di tumore. Non sono ancora misure prima e dopo: le daranno il progetto pilota all'ASL VCO e la verifica al sesto mese dei contratti VIS.

VIS PHARMA COMPASS: LA SPESA

In Abruzzo il valore prudenziale è di 808.000 € su 452,7 mln € di spesa: **1.785 € per ogni milione di euro di spesa** (892 € nel minimo). Applichiamo questo rapporto alla spesa farmaceutica 2025 di ciascuna regione (AIFA, classi A, H e C, al lordo dei payback). Per un'azienda sanitaria usiamo la quota della regione in proporzione ai residenti.

FRANKURA: I PAZIENTI

All'ASL VCO il valore è di 66.816 € su 1.100 nuovi pazienti oncologici: **60,74 € e 1,27 ore di medico per paziente**. Applichiamo questi valori ai nuovi casi di tumore di ciascuna regione (AIRTUM). Verifica: l'ASL VCO registra 6,7 schede CAS ogni 1.000 residenti, il Piemonte 7,1 nuovi casi ogni 1.000.

Valore annuo per ente

	ENTE E TERRITORIO	VIS PHARMA COMPASS valore annuo, scenario minimo e prudenziale	FRANKURA valore annuo e ore di medico liberabili
1	**ASL VCO** 163.337 residenti	da 44.000 a 88.000 €	**66.816 €** **1.392 h**
2	**ASL Caserta** 908.451 residenti	**da 280.000 a 560.000 €**	320.000 € 6.690 h
3	**ASL Salerno** 1.055.372 residenti	**da 320.000 a 650.000 €**	370.000 € 7.780 h
4	**Regione Campania** 5.582.337 residenti	**da 1,7 a 3,4 mln €**	2,0 mln € 41.130 h
5	**Regione Piemonte** 4.251.868 residenti	da 1,1 a 2,3 mln €	**1,8 mln €** **37.960 h**
6	**Regione Abruzzo** 1.269.118 residenti	**da 404.000 a 808.000 €**	500.000 € 10.500 h
7	**Regione Puglia** 3.877.395 residenti	**da 1,1 a 2,2 mln €**	**1,3 mln €** **27.210 h**
8	**Ospedale Miulli** ospedale	sui volumi della struttura	sui volumi della struttura
9	**ASL Taranto** 550.436 residenti	**da 160.000 a 320.000 €**	**190.000 €** **3.860 h**
10	**ASL Gallura** 159.222 residenti	**da 52.000 a 100.000 €**	**63.000 €** **1.320 h**
11	**Regione Liguria** 1.510.143 residenti	**da 470.000 a 940.000 €**	720.000 € 15.060 h
12	**Humanitas** ospedale	sui volumi della struttura	sui volumi della struttura
13	**AULSS 9 Scaligera** 928.622 residenti	**da 240.000 a 470.000 €**	370.000 € 7.750 h
14	**Ospedale Pederzoli** ospedale	sui volumi della struttura	sui volumi della struttura
15	**AUSL Modena** 708.340 residenti	**da 210.000 a 430.000 €**	**280.000 €** **5.930 h**

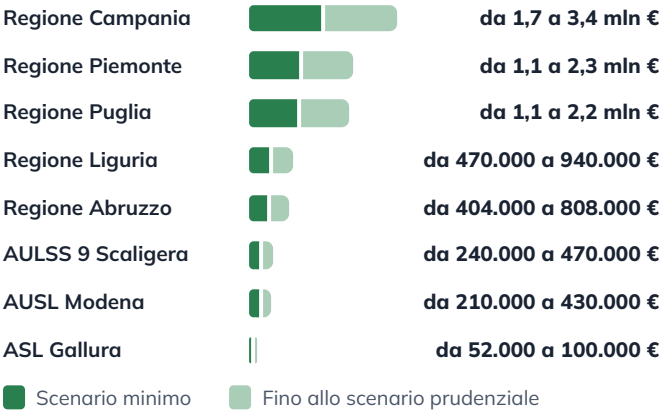
In evidenza il prodotto proposto a ciascun ente. ASL VCO (Frankura) e Regione Abruzzo (VIS) sono i casi di riferimento; gli altri valori sono ricavati in proporzione e arrotondati.

07 · QUANTO VALE

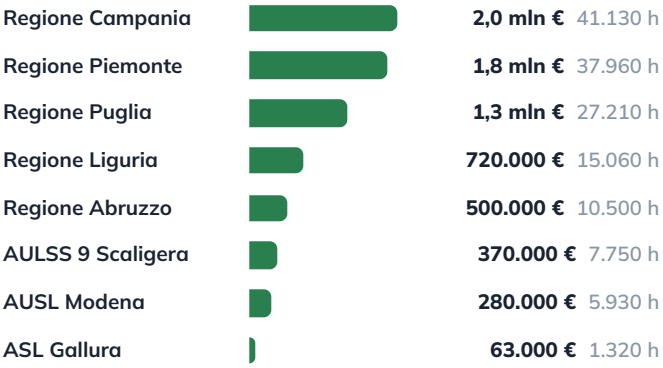
Il valore della rete e dell'Italia

Nei grafici ogni territorio compare una sola volta: le ASL di una regione che è già nella rete sono comprese nel valore della regione, e gli ospedali non sono sommati. Così i totali non contano due volte lo stesso euro. Per un ospedale il valore dipende dai suoi volumi: Frankura vale circa 61.000 € e 1.265 ore di medico l'anno ogni 1.000 nuovi pazienti oncologici.

VIS Pharma Compass, valore annuo



Frankura, valore annuo e ore di medico



Scenario minimo · Fino allo scenario prudenziale

VIS NELLA RETE

10,7 mln €

all'anno nello scenario prudenziale, 5,4 mln € nel minimo.

FRANKURA NELLA RETE

7,0 mln €

all'anno, pari a circa 147.000 ore di lavoro medico che si potrebbero restituire all'attività clinica.

INSIEME

17,8 mln €

il valore annuo potenziale dei due prodotti nei territori della rete, scenario prudenziale; 12,4 mln € nel minimo.

Su scala nazionale

da 16 a 32 mln €

all'anno: il valore di VIS sulla spesa farmaceutica italiana per acquisti diretti (18,2 mld € lordi nel 2025).

24 mln €

all'anno: il valore di Frankura su circa 390.000 nuove diagnosi, pari a 494.000 ore di lavoro medico.

Come leggere questi numeri. Sono ordini di grandezza, non valori garantiti. Il valore di Frankura è tempo medico valorizzato a 48 € l'ora: tempo restituito all'attività clinica, non un risparmio di cassa. Il valore di VIS è l'effetto di intervenire prima su opportunità che esistono già, non un risparmio prodotto dal software. La spesa di un'ASL calcolata sui residenti comprende anche quella delle aziende ospedaliere del suo territorio. I nuovi casi per regione sono le stime AIRTUM del 2019, le ultime pubblicate per regione; da allora il totale nazionale è cresciuto di circa il 5%, quindi la stima di Frankura è prudente. Il rapporto di VIS viene da una sola regione e quello di Frankura dai soli moduli A, B e C. Per ogni ente l'analisi diagnostica o il progetto pilota sostituiscono la stima con i dati dell'ente, prima di qualunque contratto.

Come guadagniamo

Canoni fissi e licenze, non quote del risparmio. Il valore per l'ente è un argomento a sostegno della decisione, non una parte del prezzo.

Proporre a un ente pubblico di pagare una quota del risparmio non ha oggi una base contabile né un precedente documentato nella sanità italiana: il risparmio di un'azienda confluisce in gran parte nella posizione regionale, il bilancio non ha una voce per remunerarlo e servirebbe un certificatore indipendente. Per questo VIS ha un canone fisso con recesso al sesto mese, e Frankura una licenza per ospedale con un canone di gestione.

Valore e canone, ente per ente

ENTE	CONFIGURAZIONE VIS	CANONE ANNUO	VALORE SU CANONE
ASL VCO	Azienda singola, M1+M2	26.000 €	da 1,2 a 2,5×
ASL Caserta	Azienda singola, tutti i moduli	72.000 €	da 3,9 a 7,7×
ASL Salerno	Azienda singola, tutti i moduli	72.000 €	da 4,5 a 9,0×
Regione Campania	Regione, 17 aziende, tutti i moduli	237.000 €	da 7,2 a 14,5×
Regione Piemonte	Regione, 18 aziende, tutti i moduli	243.000 €	da 4,7 a 9,5×
Regione Abruzzo	Regione, 4 ASL, tutti i moduli	159.000 €	da 2,5 a 5,1×
Regione Puglia	Regione, 10 aziende, tutti i moduli	195.000 €	da 5,7 a 11,4×
ASL Taranto	Azienda singola, tutti i moduli	72.000 €	da 2,2 a 4,4×
ASL Gallura	Azienda singola, M1+M2	26.000 €	da 1,5 a 2,9×
Regione Liguria	Regione, 5 aree e 3 enti ospedalieri, tutti i moduli	183.000 €	da 2,6 a 5,1×
AULSS 9 Scaligera	Azienda singola, tutti i moduli	72.000 €	da 3,3 a 6,6×
AUSL Modena	Azienda singola, tutti i moduli	72.000 €	da 3,0 a 5,9×

Canoni VIS da listino, IVA esclusa. La configurazione regionale comprende tutte le aziende sanitarie pubbliche della regione, perché il valore è calcolato sulla spesa di tutte. Per le ASL con meno di 300.000 residenti la configurazione più adatta è M1+M2, e in quel caso il valore comprende solo programmazione e acquisto, il 73% del totale. Nello scenario minimo il valore supera il canone in ogni ente, da 1,2 volte (ASL VCO) a 7,2 volte (Regione Campania). In Abruzzo, con la configurazione completa da 159.000 € l'anno, basta realizzare il 19,7% dello scenario prudenziale perché il servizio si ripaghi; con M1, M2, M3 e il benchmark per attività (M8), a 105.000 € l'anno, ne basta il 13%.

Uno scenario per i primi tre anni

Lo scenario è illustrativo: il numero di clienti è un'ipotesi, i prezzi sono quelli di listino. Ipotizziamo che i tre enti che lavorano con noi sui prototipi diventino clienti nel 2027, che una regione adotti VIS nel 2028 e una seconda nel 2029, e che Frankura arrivi a 10 centri oncologici in tre anni. Per Frankura assumiamo una licenza di 50.000 € all'ASL VCO e di 100.000 € negli altri centri, entrambe nella fascia di prezzo. Il canone annuo, non ancora quantificato, è ipotizzato al 20% della licenza dall'anno successivo all'installazione. Fino alla marcatura CE del modulo C le licenze comprendono gli altri moduli: all'ASL VCO i moduli A e B liberano da soli, secondo la stima, 1.006 ore l'anno, pari a 48.288 €.



	2027	2028	2029
VIS PHARMA COMPASS			
Analisi diagnostiche	36.000 € 4	27.000 € 3	
Contratti ASL, M1+M2+M3 (primo anno)	84.000 € 2		
Rinnovi ASL		72.000 € 2	144.000 € 4
Configurazione regionale, 4 ASL (primo anno)		182.000 € 1	
Nuovi contratti ASL (primo anno)		84.000 € 2	84.000 € 2
Rinnovo regionale			159.000 € 1
Seconda configurazione regionale (primo anno)			214.000 € 1
Totale VIS Pharma Compass	**120.000 €**	**365.000 €**	**601.000 €**
FRANKURA			
Licenze per centro oncologico	150.000 € 2	300.000 € 3	500.000 € 5
Canoni annui sui centri installati		30.000 € 2	90.000 € 5
Totale Frankura	**150.000 €**	**330.000 €**	**590.000 €**
Ricavi totali	**270.000 €**	**695.000 €**	**1.191.000 €**

A fine 2029 i ricavi ricorrenti ammontano a circa 748.000 € l'anno (558.000 € da VIS, 190.000 € dai canoni di Frankura). Il conto economico completo, con i costi di personale, infrastruttura e certificazione, sarà costruito con i partner al momento della costituzione della società.

Il mercato e chi c’è già

2,7 mld €

spesa italiana in sanità digitale nel 2025, +9% sul 2024 (Politecnico di Milano).

1,79 mld €

la parte spesa dalle strutture sanitarie nel 2024; 580 mln € dalle regioni.

18,9 mld €

medicinali acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche nel 2025 secondo il Rapporto OsMed, con un perimetro diverso dal monitoraggio AIFA dei capitoli 2 e 7.

15,63 mld €

la Missione Salute del PNRR, che ha finanziato la digitalizzazione di cui i nostri prodotti si servono.

VIS Pharma Compass

CHI	COSA FA	DIFFERENZA
IQVIA Italia Farma360	Raccoglie i consumi di tutte le aziende della Regione Calabria e fornisce cruscotti di spesa, senza costi per la Regione (decreto 14885/2025).	Un concorrente a prezzo zero. VIS risponde con opportunità quantificate in euro per l’azienda e con un recesso al sesto mese.
Maps Healthcare BI Health	Business intelligence per aziende sanitarie e regioni, forte nel Lazio. A settembre 2026 Maps Healthcare ha firmato l’accordo vincolante per rilevare BI Health a 3,7 milioni di euro, con closing previsto entro novembre.	Conferma che il segmento ha valore. VIS è costruito sul percorso farmaceutico, non su una piattaforma generale.
Cineca ARNO, CliCon	Banche dati di popolazione e analisi retrospettive per ASL e regioni, soprattutto a fini di studio.	VIS lavora sui dati dell’esercizio in corso, con segnalazioni e proiezioni per chi deve decidere.
Strumenti pubblici AIFA OsMed, società regionali	Dati aggregati gratuiti e sistemi sviluppati da società in house regionali, come LAZIOcrea.	Utili per il confronto nazionale, non per agire sulla singola azienda.

Frankura

CHI	COSA FA	DIFFERENZA
Trascrizione della visita Tandem Health, Microsoft Dragon Copilot, Nabla, Heidi, Corti con Dedalus, MioDottore	Ascoltano la visita e redigono la nota clinica. Tandem ha raccolto 100 milioni di dollari nel 2026; Corti è integrato nel software di Dedalus, tra i principali fornitori di cartelle cliniche ospedaliere in Italia.	Coprono il modulo A, che diventerà una funzione standard. Frankura punta sui moduli B e C, il lavoro per il GIC.
Software per i gruppi multidisciplinari (tumor board) Roche navify, Siemens AI-Pathway Companion, GE CareIntellect, Microsoft con Oxford	Aggregano i dati del paziente per la discussione multidisciplinare; alcuni suggeriscono come proseguire il percorso di cura.	Sviluppati per altri sistemi sanitari. Frankura è costruito sul percorso delle reti oncologiche italiane (CAS e GIC in Piemonte e Valle d’Aosta) e sulle linee guida AIOM.
Startup italiane ReportAId, Alfadocs	Strutturano referti o note, soprattutto in ambito privato e ambulatoriale.	Non coprono il percorso oncologico dall’accoglienza al referto del GIC.

Come un ente acquista i nostri prodotti

Ogni contratto parte da una prova sui dati dell'ente, rispetta le soglie del Codice dei contratti pubblici e cresce dall'azienda alla regione.

PASSO 1

La prova

VIS: analisi diagnostica di tre settimane, 9.000 €, senza installazione. Frankura: progetto pilota con misure prima e dopo, come quello proposto all'ASL VCO.

PASSO 2

L'azienda

Affidamento diretto se il valore stimato dell'appalto per l'intera durata, IVA esclusa, è inferiore a 140.000 € (D.Lgs. 36/2023, art. 50): per esempio tre anni di VIS M1+M2+M3 (114.000 €) o una licenza Frankura da 50.000 €. Oltre, procedura negoziata.

PASSO 3

La verifica

Attivazione in novanta giorni. Al sesto mese si controllano gli indicatori concordati; se non sono raggiunti, l'ente può recedere senza oneri.

PASSO 4

La regione

Quando il perimetro cresce: procedura negoziata sotto la soglia europea, gara europea o accordo quadro regionale oltre. Una configurazione a quattro ASL vale 500.000 € in tre anni.

Il frazionamento artificioso dell'appalto per restare sotto soglia è vietato (D.Lgs. 36/2023, art. 14) e il principio di rotazione (art. 49) limita gli affidamenti diretti ripetuti allo stesso operatore economico: se analisi diagnostica e contratto vanno allo stesso operatore, il secondo affidamento richiede una motivazione specifica, che prepariamo con l'ente. Presentiamo fin dall'offerta il percorso amministrativo corretto.

L'ordine in cui procediamo

2027

Dalla prova ai contratti

L'ASL Caserta e l'ASL Salerno passano dalla prova al contratto VIS; l'ASL VCO, ottenuta l'approvazione regionale, dal progetto pilota alla licenza di Frankura. Analisi diagnostiche con l'AULSS 9, l'AUSL Modena e l'ASL Taranto.

2028

La prima regione

Con due ASL campane attive e i dati abruzzesi già analizzati, proponiamo la configurazione regionale in Abruzzo o in Campania. Frankura si estende nella Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

2029

La seconda regione

Proponiamo la configurazione regionale in Liguria o in Puglia, dove abbiamo un referente regionale o più enti nella rete. Offriamo inoltre i prodotti direttamente agli ospedali privati accreditati della rete.

Come troviamo i clienti

- **Contatti diretti** con direttori generali, farmacisti e oncologi: i referenti dei 15 enti di questo piano.
- **La rete della Fondazione**: i consulenti, le società scientifiche, i progetti di ricerca con ospedali e università.
- **Congressi di settore** per farmacisti ospedalieri e oncologi, dove la misura fatta in un ente è l'argomento più forte per il successivo.

Chi siamo



Guido Putignano

FONDATORE E PRESIDENTE

Ingegnere biomedico, con esperienze all'ETH di Zurigo, a Harvard e al MIT.



Mimma Leone

DIRETTRICE OPERATIVA

Avvocata e imprenditrice. Segue organizzazione e operazioni.



Margherita Basile

LEGALE

Avvocata. Segue governance, contratti e conformità normativa.



Olufemi Olusola

SVILUPPO SOFTWARE

Biostatistico, con dieci anni di esperienza; lavora su agenti di IA e dati clinici.

FA

Federico Arangath Joseph

SVILUPPO SOFTWARE

Sviluppa il software dei prodotti.



Saria Miccoli

COMUNICAZIONE

Designer. Cura l'identità visiva e la comunicazione.

Consulenti



Daniela Marotto
Reumatologa, Collegio Reumatologi Italiani (CReI)



Pasquale Persico
Market access, Gilead Sciences



Roberto De Ponti
Managing Director, 3B Future Health Fund

Consiglio della Fondazione: Guido Putignano, Mimma Leone e Carmine Pisano.

Le competenze che aggiungiamo

Qualità e regolatorio

Sistema qualità ISO 13485 e marcatura CE del modulo C di Frankura.

Vendite alla PA

Gare, accordi quadro e rapporti con le centrali di committenza regionali.

Integrazione

HL7 FHIR e connettori verso cartelle cliniche e gestionali di farmacia.

Farmacia ospedaliera

Un farmacista senior che accompagni le direzioni nell'uso di VIS.

Governance

Oggi Hadi Health è un progetto della Fondazione bioERGOtech ETS, senza personalità giuridica propria. Il passo successivo è costituire una società che firmi i contratti, ne risponda e regga il percorso di certificazione di Frankura.

Il rapporto tra Fondazione e società sarà regolato da un accordo su proprietà intellettuale, uso dei dati e del nome. La Fondazione resta il luogo della ricerca e della validazione; la società quello dei prodotti e dei contratti. Struttura societaria e ingresso dei partner si definiscono insieme a loro.

Cosa può andare storto, e cosa facciamo

RISCHIO	COME LO GESTIAMO
Frankura come dispositivo medico	Il modulo C propone le opzioni delle linee guida e rientra con ogni probabilità nella regola 11 del Regolamento (UE) 2017/745, almeno in classe IIa e, poiché orienta scelte terapeutiche in oncologia, verosimilmente in classe IIb: servono sistema qualità ISO 13485, valutazione clinica e organismo notificato. Come sistema di IA ad alto rischio è soggetto anche al Regolamento (UE) 2024/1689, con obblighi applicabili dal 2 agosto 2028 dopo la modifica del Regolamento (UE) 2026/1744. I moduli A, B e D organizzano dati e documenti e si possono adottare prima; una valutazione regolatoria formale dovrà confermare questa lettura. Fino alla marcatura CE, anche nei progetti pilota il modulo C orienta decisioni sui pazienti solo nell'ambito di un'indagine clinica.
Tempi degli acquisti pubblici	Analisi diagnostica e affidamento diretto sotto soglia per partire; procedura negoziata, gara europea o accordo quadro quando il perimetro cresce. Il recesso al sesto mese riduce il rischio per l'ente e rende più semplice la decisione di partire.
Chi risparmia non è chi paga	Il risparmio farmaceutico di un'azienda confluisce in buona parte nella posizione regionale. Per questo puntiamo alla configurazione regionale, dove chi paga e chi beneficia coincidono.
Concorrenti grandi o gratuiti	La trascrizione della visita diventerà una funzione standard dei software clinici, e in Calabria IQVIA offre il monitoraggio della spesa senza costi. Puntiamo dove la concorrenza è debole: la preparazione del GIC e le opportunità quantificate in euro per la singola azienda.
Dati sanitari	L'ente resta titolare del trattamento e il fornitore agisce come responsabile (GDPR, art. 28). VIS lavora su dati aggregati e, dove serve il dettaglio, su dati pseudonimizzati all'origine. Frankura tratta invece dati clinici nominativi, compreso l'audio della visita (modulo A): installiamo solo dopo la valutazione d'impatto dell'ente, per la quale forniamo la documentazione tecnica. Per entrambi i prodotti, elaborazione nell'Unione Europea o presso l'ente e registro degli accessi.
Stime da confermare	I valori di questo piano vengono da due casi di riferimento, costruiti sui dati di due enti, e da dati pubblici. Ogni contratto parte da una prova sui dati dell'ente e da indicatori misurati prima e dopo.
Persone chiave e società da costituire	Oggi il progetto si regge su poche persone chiave e non è ancora una società. Per questo cerchiamo partner: per costituire la società, aggiungere competenze regolatorie e commerciali e distribuire le responsabilità su più persone.

Le partnership che cerchiamo

Non chiediamo un importo. Cerchiamo partner che portino ciò che ci manca per passare dai primi enti a decine di clienti.

AZIENDE SANITARIE E REGIONI

Adottare e misurare

Un'analisi diagnostica o un progetto pilota sui propri dati, con indicatori concordati prima di iniziare. In cambio, risultati misurati sul proprio perimetro e la possibilità di pubblicarli insieme alla Fondazione, con l'ente fra gli autori.

PARTNER INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

Integrare e distribuire

Fornitori di cartella clinica, gestionali di farmacia e integratori di sistema: l'accesso ai dati in modo standard e un canale verso i loro clienti. In cambio, una funzione che i loro sistemi non hanno.

PARTNER CLINICI E SCIENTIFICI

Validare

IRCCS, reti oncologiche, università e società scientifiche per la valutazione clinica di Frankura e le pubblicazioni. È il lavoro naturale della Fondazione.

PARTNER FINANZIARI

Costituire la società

Fondi specializzati in salute e investitori industriali con cui costituire Hadi Health, sostenere i primi tre anni e il percorso di certificazione. Struttura e condizioni si definiscono insieme.

Obiettivi per il 2027

- Costituire la società con i partner e firmare l'accordo con la Fondazione.
- Portare l'ASL Caserta e l'ASL Salerno dalla prova al contratto VIS.
- Ottenere l'approvazione regionale e l'accordo scritto per il progetto pilota all'ASL VCO; misurare prima e dopo e passare alla licenza.
- Svolgere almeno quattro analisi diagnostiche VIS in altri enti della rete.
- Avviare il sistema qualità e la valutazione clinica del modulo C di Frankura.
- Pubblicare i risultati dei progetti pilota con la Fondazione.

Come iniziare. Per un ente, il primo passo è l'analisi diagnostica: tre settimane e 9.000 € per vedere, sui propri dati, quanto vale VIS. A un partner proponiamo un primo incontro dedicato a uno dei 15 enti della rete.

APPENDICE

Ipotesi e fonti

Ipotesi

- Valore di VIS proporzionale alla spesa farmaceutica: 0,18% della spesa nello scenario prudenziale, 0,09% nel minimo, come in Abruzzo. Spesa regionale: AIFA 2025, acquisti diretti di classe A, H e C al lordo dei payback (Tab. 8.1).
- Spesa e nuovi casi di un'ASL pari a quelli della regione in proporzione ai residenti (ISTAT, 1° gennaio 2025). Il territorio dell'ASL VCO comprende 81 comuni e 163.337 residenti.
- Valore di Frankura proporzionale ai nuovi pazienti oncologici: 60,74 € e 1,27 ore per paziente, come all'ASL VCO (moduli A, B e C, 48 € l'ora).
- Nuovi casi per regione: stime AIRTUM 2019, le più recenti pubblicate per regione. Totale nazionale: circa 390.000 (AIOM e AIRTUM, 2024 e 2025).
- Configurazione regionale di VIS: tutte le aziende sanitarie pubbliche della regione (ASL, aziende ospedaliere, AOU e IRCCS pubblici), perché la loro spesa rientra nel dato AIFA su cui si calcola il valore: 4 in Abruzzo, 17 in Campania, 18 in Piemonte, 10 in Puglia; in Liguria le cinque aree sociosanitarie di ATS Liguria, l'azienda sanitaria unica regionale dal 1° gennaio 2026, e tre enti ospedalieri.
- Scenario di ricavo: numeri di clienti ipotizzati; licenza di Frankura 100.000 € per centro (50.000 € all'ASL VCO); canone annuo di Frankura pari al 20% della licenza, ipotesi da validare.

Fonti

- VIS Pharma Compass, Descrizione del prodotto e Percorso Euro Farmaceutico (documenti interni).
- Proposta di progetto all'ASL VCO, versione 6, 1° giugno 2026 (documento interno).
- Hadi Health, bozza di piano industriale, giugno 2026 (documento interno).
- AIFA, Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale, gennaio-dicembre 2025, consuntivo. aifa.gov.it/documents/20142/3073807/Monitoraggio_Spesa_gennaio-dicembre-2025_consuntivo.pdf
- AIFA, Rapporto OsMed 2025. aifa.gov.it/-/aifa-pubblica-rapporto-osmed-2025
- ISTAT, popolazione residente al 1° gennaio 2025. demo.istat.it; Ministero della Salute, corrispondenze ASL e comuni 2024. dati.salute.gov.it
- AIRTUM e AIOM, I numeri del cancro in Italia, edizioni 2019, 2024 e 2025. aiom.it; epicentro.iss.it/tumori/pdf/NC2019-operatori-web.pdf
- Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, elenchi CAS e GIC. reteoncologica.it
- Osservatorio Sanità Digitale, Politecnico di Milano, edizioni 2025 e 2026.
- Camera dei deputati, Risorse della Missione Salute del PNRR. temi.camera.it
- Legge 23 settembre 2025, n. 132; D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 117/2017; Regolamenti (UE) 2017/745, 2024/1689, 2025/327 e 2026/1744.
- Ruoli dei referenti: siti degli enti, atti pubblicati e stampa, consultati a ottobre 2026.

Il dettaglio di ogni numero, con la fonte e la data, è disponibile su richiesta.